

INFORME 000001-2026GR.LAMB/GERESA-AIS-FEAS [516241404 - 1]

CINTHIA CATHERINE PALACIOS MARIÑO
JEFA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD
COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD - SALUD LAMBAYEQUE

ASUNTO: SOLICITO OPINION TECNICA

Me dirijo a Ud., para solicitar la OPINION TECNICA sobre la necesidad de **IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE SEGUIMIENTO CLINICO THESIA** como herramienta de seguimiento de hipertensión en la Región Lambayeque, informar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

- En reuniones virtuales a través de la plataforma zoom llevadas a cabo los días 27 de Febrero y 09 de Marzo del año 2026; promovidas por el Seguro Integral de Salud del Ministerio de Salud; con participación de los Jefes de Oficinas de Dirección Ejecutiva de Salud Integral de las Personas (DESIP), Centro de Sistemas de Información(CSI), Atención Integral de Salud(AIS), Oficina de Aseguramiento en Salud de la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque ; se realizó la presentación de iniciativas digitales innovadoras con el desarrollo de una plataforma digital dedicada al seguimiento de la hipertensión arterial. Gracias a una aplicación móvil que utiliza inteligencia artificial, los pacientes pueden medir su presión arterial a través de la cámara de su smartphone y recibir seguimiento médico a distancia. La plataforma también permite a los establecimientos de salud acceder a los datos de los pacientes y mejorar el monitoreo, la prevención y la atención de las enfermedades cardiovasculares. Esta plataforma integra una tecnología de medición de la presión arterial basada en métodos científicamente validados, que utilizan el análisis óptico de señales fisiológicas. Esta funcionalidad es proporcionada por un software de medición que está sujeto a la normativa aplicable a dispositivos médicos. En este sentido, dicho software cuenta con las evaluaciones regulatorias correspondientes, incluyendo la evaluación por la DIGEMID y la obtención del registro sanitario.
- El PP 018, denominado Enfermedades No Transmisibles; tiene como objetivo Reducir la morbilidad, mortalidad y discapacidad por Enfermedades No Transmisibles en la población y se consolida como la columna vertebral de la lucha contra las enfermedades cardiovasculares en el Perú, que prioriza la detección temprana y el control preventivo para evitar complicaciones costosas como el infarto o la insuficiencia renal. A nivel regional, la Hipertensión refleja un desafío para la salud pública, por una prevalencia estimada de entre el 19.6% y el 22.7% en la población adulta, con un marcado ascenso en el grupo de adultos mayores de 70 años, donde alcanza el 41%. Este escenario presenta una brecha crítica de diagnóstico, dado que aproximadamente el 38% de los afectados desconoce su condición, y se ve agravado por una alta tasa de comorbilidad metabólica (37.1% de la población presenta factores de riesgo asociados como obesidad o diabetes).

II. BASE LEGAL

- Ley N° 26842 Ley General de Salud.
- Ley N° 32513 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2026.
- Ley N° 30421, Ley Marco de Telesalud, y su reglamento (D.S. N° 005-2021-SA)
- Ley N° 30024, "Ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas.
- Ley N° 29733 de Protección de Datos Personales .
- Resolución Ministerial N° 031-2015/MINSA, aprueba Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico, Tratamiento y Control de la Enfermedad Hipertensiva".

III. ANÁLISIS

Sobre el Dispositivo:

1. Según la bibliografía proporcionada para esta plataforma, DICHA PLATAFORMA: SERVICIO DE SOPORTE AL TELESEGUIMIENTO DE PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL, se realiza en el marco de un protocolo médico prescrito, donde los pacientes utilizarán un aplicativo móvil donde se incluye la herramienta digital de medición de la presión arterial. El uso se realizará en el domicilio bajo supervisión clínica remota (teleseguimiento) y seguimiento profesional conforme a los lineamientos establecidos por la institución de salud.

El software del producto sanitario está diseñado para la medición no invasiva de la presión arterial (mmHg) y la frecuencia cardíaca (ppm) en 60 segundos o menos, en pacientes adultos de 18 años o más, independientemente de su origen étnico o género. Antes de utilizar este producto, el profesional sanitario debe estudiar cuidadosamente las indicaciones, la finalidad prevista, las recomendaciones, las advertencias y las instrucciones, así como la información disponible específica del producto, por lo que el servicio necesita capacitar a los profesionales de la salud, pero no se hace responsable de los problemas derivados de un uso del dispositivo distinto de los indicados y de cuestiones similares que escapen al control de dicha plataforma

2.- Con respecto a la plataforma en mención se indica que; el paciente accede a la aplicación móvil para la activación de su cuenta, su registro de mediciones, la programación de citas y las consultas de indicaciones médicas, las teleconsultas, solicitudes de exámenes, prescripción médica, entre otros.

Por otro lado con OFICIO MULTIPLE N° 000001-2026-GR.LAMB/GERESA-CSI [516209781-1], derivado del INFORME N° D000027-2026-OGTI-OIDT-ESPD-MINSA, sobre el acceso a los servicios de integración de datos de salud HIS, REFCON y RENIEC, en el marco de la política de interoperabilidad y estandarización de la información sanitaria a nivel nacional, el Jefe de Centro de Sistemas de Información de esta GERESA, comunica que **no corresponde la habilitación de accesos externos directos** a dichos servicios de integración, a fin de evitar duplicidad de registros o inconsistencias en la información sanitaria, lo cual debe de ser considerada en la implementación mediante estándares de interoperabilidad.

En ese sentido, si bien la plataforma contribuiría a un seguimiento del paciente hipertenso, su implementación técnica, debe garantizar con los estándares de interoperabilidad y seguridad establecidos por el Ministerio de Salud (MINSA). De lo contrario, no se acredita la integración con los sistemas de información institucionales, por lo que no se debe poner en riesgo el registro de la historia clínica electrónica y la continuidad asistencial.

Sobre la situación en la Región Lambayeque:

3. Si bien es cierto, es importante mejorar el control y seguimiento clínico de pacientes diagnosticados con HTA en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud Lambayeque, resulta primordial contar con un padrón nominal de pacientes identificados con este diagnóstico que garantice un seguimiento eficaz; padrón con el que actualmente no se cuenta en la región, debido a múltiples factores entre ellos la brecha de recurso humano exclusivo para la atención de enfermedades no transmisibles, el equipamiento (bienes estratégicos) insuficiente en las IPRESS nivel de atención, así como la falta de equipamiento médico a nivel regional validado por la OPS para la atención, que garantice una correcta toma de presión arterial, como parte del diagnóstico de éstos pacientes

4. Bajo ese contexto, una vez instaurado el padrón nominal; la implementación de un servicio tecnológico de soporte al teleseguimiento clínico en el primer nivel de atención como el que esta plataforma ofrece, contribuiría eficazmente a mejorar la continuidad de la atención, facilitar el acceso oportuno al seguimiento médico y optimizar la gestión estructurada de la información clínica, además de que se garantice que esto se de en concordancia con los lineamientos del Ministerio de Salud en materia de enfermedades crónicas no transmisibles, Telesalud y otros.

5. Derivado de lo antes descrito, actualmente las IPRESS se encuentran en un proceso de fortalecimiento de los servicios de salud en el marco del modelo de cuidado integral por curso de vida, que requieren profesionales de la salud con competencias en el manejo de los Daños No Transmisibles. A pesar de la implementación de estrategias normativas como la iniciativa HEARTS en el primer nivel de atención, dentro de los puntos más críticos en la región está la brecha de recursos humanos para la atención exclusiva de Daños No Transmisibles, así como los consultorios difenciados que garanticen una atención integral; ya que se estima que cerca del 38% de los hipertensos no saben que lo son. Por otro lado, la falta de Adherencia al Tratamiento es un problema común, especialmente en niveles socioeconómicos bajos donde el acceso constante a la medicación o el seguimiento médico se dificulta, aunado a eso solo un 70% de quienes reciben tratamiento logran mantener sus niveles de presión arterial bajo control (< 140/90 mmHg).

6. Según el reporte operacional, con corte de febrero del 2026 existen un promedio de 1076 usuarios diagnosticados con Hipertensión Arterial, donde se puede identificar que la población con mayor cantidad de pacientes corresponde a la jurisdicción del establecimiento de salud José Olaya, seguido de José Leonardo Ortiz, con aproximadamente 55 pacientes identificados como pacientes controlados, esto se grafica en la siguiente tabla

N	IPRESS	Nivel	Atenc.	Atend.	Intens.	% Total
1	Hospital Regional Lamb.	III-1	5,600	3,605	1.55	5.4%
2	José Olaya	I-3	4,550	1,157	3.93	4.4%
3	José Leonardo Ortiz	I-3	3,598	952	3.78	3.5%
4	Pedro Pablo Atusparias	I-3	3,506	745	4.71	3.4%
5	La Victoria Sector I	I-3	3,037	563	5.39	2.9%
6	El Bosque	I-3	2,678	706	3.79	2.6%
7	H.R.D. Las Mercedes	II-2	2,672	1,861	1.44	2.6%
8	Reque	I-4	2,601	502	5.18	2.5%
9	Toribia Castro Chirinos	I-4	2,540	884	2.87	2.5%
10	Hospital Belén – Lamb.	II-1	2,328	1,263	1.84	2.3%
11	C.S. Pueblo Nuevo	I-3	2,294	678	3.38	2.2%
12	Santa Rosa	I-3	2,267	399	5.68	2.2%
13	Verónica Stack de Tomis	I-3	2,165	514	4.21	2.1%
14	Cerrópón	I-3	2,044	607	3.37	2.0%
15	San Antonio	I-3	2,022	524	3.86	2.0%
16	C.S. San Martín – Lamb.	I-3	1,998	392	5.10	1.9%
17	José Quiñonez Gonzales	I-2	1,766	419	4.21	1.7%
18	Ciudad Eten	I-3	1,616	418	3.87	1.6%
19	Monsefú	I-3	1,581	479	3.30	1.5%

Bajo el panorama antes mencionado, es importante considerar la instalación de un padrón nominal regional, ya que la posterior implementación de una plataforma de teleseguimiento a pacientes con diagnóstico de Hipertensión Arterial en Lambayeque, con congruencia e interoperabilidad entre paciente e IPRESS; fortalecería y se sustenta en la necesidad crítica de cerrar la brecha de control de la presión

arterial en estos pacientes, que actualmente afecta al 30% de los pacientes tratados, no controlados y mitigar el porcentaje de aquellos usuarios que contemplen un subdiagnóstico, mediante el monitoreo remoto y la vigilancia digital. Un servicio a través de alertas automatizadas y telemonitoreo sincrónico/asincrónico, permite una intervención oportuna ante crisis hipertensivas y reduciendo la saturación en los servicios de urgencias, esta solución tecnológica no solo descongestionaría el primer nivel de atención, sino que reduciría significativamente la carga de morbilidad por eventos cardiovasculares mayores, cumpliendo con el marco normativo de la Ley N° 30421 y garantizando una gestión basada en evidencia con una mayor capacidad de respuesta epidemiológica regional.

IV.CONCLUSION(ES)

- Para el uso de esta plataforma se debe VALIDAR la Interoperabilidad, dado que las mediciones deberán integrarse automáticamente al registro clínico electrónico normados.
- El Programa Presupuestal 018, no cuenta con disponibilidad presupuestal en ninguna fuente de financiamiento para el presente año, según lo programado, se deben realizar las modificaciones presupuestales en la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias y se debe de solicitar la opinión al SIS (UDR) sobre la viabilidad de este financiamiento.
- Con la implementación de esta plataforma, se garantizaría un control y seguimiento y el cierre de brechas de un control oportuno a dichos pacientes según el reporte HIS, se sugeriría que esta se implemente en los establecimientos donde se encuentra la mayor identificación de pacientes con este diagnóstico y que cuente con el equipamiento y el personal necesario, sugiriendo que esta pueda ser el C.S José Olaya y/o C.S José Leonardo Ortiz. Sin embargo, ya que la población fluctuaría en promedio a 100 (cien) pacientes.
- Los beneficios que se prevé en este servicio, permitirán reducir las complicaciones de la hipertensión arterial, como son: los Infartos cardíacos, Accidentes Cerebros Vasculares, Daño Renal, Retinopatía hipertensiva, Insuficiencia Cardíaca y otras; esto permitirá reducir los sobrecostos de dichas complicaciones, así como mejorar la calidad de vida de los pacientes hipertensos y su esperanza de vida al nacer.
- Elevar el presente informe a la Oficina de Aseguramiento en Salud, en ninguna fuente de para su opinión técnica y viabilidad, además garantice el presupuesto por D y T dado que el programa no cuenta con disponibilidad presupuestal financiamiento para el presente año.

V. RECOMENDACION(ES)

- PRIORIZAR el gasto en equipamiento básico validado por la OPS para estandarizar la toma de Presión Arterial que garantice un correcto seguimiento
- IMPLEMENTAR y estandarizar un padrón nominal a nivel regional de usuarios con este diagnóstico
- Elevar el presente informe al Centro de Sistemas de Información (CSI) y al área de Estadística de esta Gerencia Regional de Salud, para el análisis y validación de interoperabilidad entre los sistemas y dispositivos a utilizar.
- Pedir Opinión a la Unidad Funcional de Servicios de Salud (Teleatiendo) para su opinión técnica y viabilidad.
- Pedir Opinión a la UDR del SIS para la viabilidad financiera en el financiamiento bajo esta Fuente.

Es todo cuanto informo a usted.

Atentamente.

Firmado electrónicamente
FIORELLA ELIZABET ARBOLEDA SANDOVAL
COORDINADORA REGIONAL DE DAÑOS NO TRANSMISIBLES
Fecha y hora de proceso: 26-03-2026 / 10:20:37